

Sujet 19: DÉSHYDRATATIONS AIGUES DE L'ENFANT

Q1 : La déshydratation aigue du nourrisson :

- A. Est définie par un déficit non compensé en eau et en électrolytes
- B. Est définie par un déficit non compensé en eau
- C. Complique, le plus souvent, une gastroentérite aigue
- D. Le pronostic est conditionné par le risque de choc infectieux
- E. Le pronostic a été amélioré par l'utilisation des SRO

Q2 : La composition des compartiments hydriques chez les nourrissons se caractérise par :

- A. L'eau totale représente 75% du poids corporel
- B. L'eau totale représente 65% du poids corporel
- C. L'eau extracellulaire représente 50% du poids corporel
- D. L'eau extracellulaire représente 40% du poids corporel
- E. L'eau intracellulaire représente 30 à 40% du poids corporel

Q3 : Parmi les facteurs qui expliquent la susceptibilité des nourrissons au risque de déshydratation aigue on retient :

- A. La proportion élevée qu'occupent l'eau totale intracellulaire (50% de l'eau totale)
- B. Les besoins hydriques élevés par comparaison à l'adulte et au grand enfant
- C. Un taux de renouvellement de la composante liquidienne de l'organisme beaucoup plus lent
- D. Une immaturité de la fonction rénale avec des difficultés de concentration des urines
- E. Une dépendance de son entourage quant à ses apports en eau et en sels minéraux.

Q4 : En faveur de la déshydratation extracellulaire on retient :

- A. Le pli cutané
- B. La sècheresse des muqueuses
- C. La dépression de la fontanelle antérieure
- D. Crises convulsives
- E. L'oligurie

Q5 : En faveur de la déshydratation intracellulaire on retient :

- A. La fièvre
- B. Les troubles de la conscience
- C. La soif intense
- D. La sècheresse de la langue
- E. Oligurie

Q6 : En faveur de la déshydratation sévère (stade II) on retient :

- A. Une perte pondérale entre 5 et 10%
- B. Hyponatrémie < à 125 meq/L
- C. Hypokaliémie < à 3,5 meq/L
- D. Un déficit hydrique > 100 ml/kg/j
- E. Un score de déshydratation > à 8

Q7 : La réhydratation orale doit être privilégiée en dehors de :

- A. Acidose métabolique
- B. Déshydratation avec un déficit hydrique >10%.
- C. Hyponatrémie < à 125 meq/L
- D. Troubles de la conscience
- E. Suspicion d'une urgence chirurgicale

Q8 : Le traitement de la déshydratation légère (Stade 1) consiste à :

- A. Administrer la SRO en prises fractionnées de 5 à 10 ml toutes les 1 à 2 minutes
- B. Arrêter l'allaitement maternel pendant 4 à 6 heures
- C. Arrêter le lait artificiel pendant 4 à 6 heures
- D. Compenser le déficit hydrique sur 12 h en cas d' hyponatrémie
- E. Arrêter la réhydratation orale après la normalisation de l'état d'hydratation

Q9 : La réhydratation parentérale consiste à :

- A. Un remplissage vasculaire par du sérum physiologique isotonique à 9‰ 20ml/kg
- B. Puis une perfusion de sérum glucosé à 5% avec, par 500 ml 76mEq/l
- C. Administrer la moitié des pertes les premières 4 heures
- D. La réhydratation parentérale sera faite sur 48 heures en cas de déshydratation hyponatrémique
- E. La réhydratation parentérale sera faite sur 48 heures en cas de déshydratation hypernatrémique

Q10 : La réalimentation dans la déshydratation légère :

- A. Poursuivre l'allaitement maternel pendant la réhydratation.
- B. Reprendre l'allaitement artificiel après 4 heures de réhydratation orale.
- C. Reprendre l'alimentation avec un hydrolysate de protéines du Lait de vache (Pepti Junior®) chez les nourrissons âgés entre 3 et 6 mois.
- D. En cas de diversification déjà acquise, privilégier les aliments riches en fibres
- E. En cas de diversification déjà acquise, privilégier les glucides complexes

Q11 : Parmi les complications immédiates de la déshydratation on retient :

- A. Insuffisance cardiaque
- B. L'état de choc hypovolémique
- C. La thrombose des veines intracrâniennes
- D. Les crises convulsives
- E. L'hématome sous dural

Q12 : Parmi les complications tardives de la déshydratation on retient :

- A. La dénutrition
- B. L'insuffisance surrénalienne
- C. L'hématome sous dural
- D. La thrombose des veines rénales
- E. Le retard mental

Q13 : Parmi les moyens de prévention de la déshydratation on retient :

- A. L'allaitement maternel
- B. L'alimentation avec un Lait artificiel sans lactose
- C. L'alimentation avec un hydrolysate de protéines du Lait de vache (Pepti Junior®)
- D. L'antibioprophylaxie
- E. Réhydratation orale en cas de diarrhée aiguë

CAS CLINIQUE

Nourrisson âgé de 9 mois sans antécédents pathologiques notables amené pour diarrhée faite des selles liquidiennes à raison de 6 selles par jour évoluant depuis 2 jours associée à une fièvre à 38,5 °C sans de vomissements. Pas des cas similaires dans la famille

À l'examen :

- Température 38,7 °C
- Fréquence cardiaque : 100 b/minute
- Fréquence respiratoire : 50/minute
- TRC : < 3 secondes
- Pli cutané pâteux
- Fontanelle antérieure légèrement déprimé
- Bon état neurologique

Q1 : Le score de déshydratation pour ce nourrisson est à :

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

Q2 : La conduite à tenir consiste à :

- A. Hospitaliser le nourrisson
- B. Administrer une SRO : 5-10 ml toutes les 1-2 minutes
- C. Prescrire une antibiothérapie
- D. Arrêter le lait artificiel pendant 12 heures
- E. Arrêter l'allaitement maternel 4 heures

Le nourrisson a été réadressé à domicile. 24 heures après son retour il a présenté des vomissements alimentaires 3 fois par jour. Les parents ont reconsulté.

À l'examen il était apyrétique avec **un score de déshydratation à 6**

Urée sanguine : 9 mmol/L Créatinine sanguine : 60 µmol/L

Natrémie : 142 mmol/L kaliémie : 3,8 mmol/L

pH : 7,32 HCO₃⁻ : 19 mmol/L

Q4 : Les pertes hydriques sont estimées à :

- A. 4%
- B. 7%
- C. 11%
- D. 13%
- E. 15%

Q3 : La conduite à tenir consiste à :

- A. Hospitaliser le nourrisson
- B. Remplissage vasculaire
- C. Administrer des bicarbonates de sodium
- D. Commencer la réhydratation par voie orale
- E. Administrer la moitié des pertes en 12 heures

Au cours de l'hospitalisation aggravation de la diarrhée à raison de 12 selles liquidiennes par jour.

La fréquence cardiaque est à 120 /minute le TRC est à 5 secondes les extrémités sont froides et la TA est à 65/35

Q5 : Quelles votre conduite à tenir :

- A. Administrer le sérum physiologique 10 ml/kg à Flot
- B. Administrer le sérum physiologique 20 ml/kg à Flot
- C. Après amélioration de l'état hémodynamique administrer du sérum glucosé 5% avec 76 meq/L du NaCl, 1 ampoule de KCL et 1 ampoule de gluconate de calcium
- D. Administrer la moitié des pertes en 4 heures
- E. Administrer la moitié des pertes en 24 heures